

P E P T I Q M X

GUÍA EDITORIAL · VOLUMEN I
· 2026

Beyond Biology. Hack your limits.

14 LÍNEAS RESEARCH-GRADE
VERIFICADAS POR JANOSHIK ·
ISO/IEC 17025
HPLC ≥ 99% · COA PÚBLICO
POR LOTE
80+ REFERENCIAS PEER-
REVIEWED



Material exclusivo para investigación de laboratorio · El uso
es responsabilidad de quien lo aplique

PREFACIO · POR QUÉ EXISTIMOS

Pureza que **no se declara,** **se verifica.**

Empezamos PEPTIQ porque estábamos cansados de comprar péptidos que prometían 99% de pureza en su empaque y entregaban 87% en el cromatograma. Cansados de marcas mexicanas que vendían "research peptides" sin un solo COA público en su sitio. Cansados de pagar premium por commodities reetiquetados.

PEPTIQ es una marca editorial de péptidos research-grade construida sobre una sola obsesión: **cada lote tiene su Certificado de Análisis publicado en peptiqmx.com antes de salir a venta.** El laboratorio es Janoshik Analytical, en Praga, acreditado bajo ISO/IEC 17025 — el mismo que usan las marcas premium de Estados Unidos y Europa Occidental.

Esta guía es la documentación técnica de 14 líneas. No es una pieza de marketing — es el material que dimos primero a las clínicas de medicina estética, longevidad y rendimiento que nos pidieron entender, antes de comprar, qué es lo que estaban pidiendo a sus sujetos de investigación que se inyectaran.

Cada protocolo aquí descrito proviene de literatura peer-reviewed citada al final de cada capítulo. Cada dosis, cada frecuencia, cada duración de ciclo está construida sobre estudios clínicos públicos. Si una afirmación no tiene fuente verificable, no aparece en estas páginas.

Lee con calma. Marca lo que te interese. Cuando estés listo, escríbenos por WhatsApp y te mandamos el COA del lote que te interese — antes, no después, de tu compra.

— *Edson Noyola*

FUNDADOR · PEPTIQ MX



JANOSHIK ANALYTICAL · HPLC MONITOR · PRAGA

LA REGLA PEPTIQ

Si no se puede **verificar**, no entra al catálogo. Si HPLC muestra menos de **99% pureza**, se rechaza el lote. Sin excepciones, sin negociación.

Cada línea resuelve algo distinto.

Cada capítulo describe mecanismo celular, usos reportados en literatura, protocolo (dosis · frecuencia · vía · duración), stack clínico recomendado, observaciones de seguridad y bibliografía peer-reviewed. Cuatro filtros para encontrar tu línea.

01 · RECUPERACIÓN

Tendón · ligamento · mucosa

BPC-157 · TB-500 · Wolverine Stack · KPV. Para deportistas, post-cirugía, tendinitis crónica, intestino inflamado, rehabilitación ortopédica.

02 · GLOW

Piel · cabello · colágeno

GHK-Cu · GLOW Trinity · AHK-Cu. Anti-aging, post-procedimiento estético, alopecia incipiente, firmeza menopáusica, fotoenvejecimiento.

03 · PERFORMANCE

Composición · GH endógena

CJC-1295 + Ipamorelin · Tesamorelin. Hipertrofia, recovery, sueño profundo, recomposición ejecutiva, sarcopenia post-45.

04 · LONGEVIDAD

Mitocondria · telómeros

NAD+ · Epithalon · Highlander Stack. Energía celular, brain fog, fatiga 35+, ritmos circadianos, edad biológica epigenética.

05 · COMPOSICIÓN

Pérdida de peso · grasa visceral

Retatrutide · Semaglutide · Cagrilintide · Tesamorelin. Triple agonista GLP-1/GIP/Glucagón, NAFLD, obesidad metabólica.

06 · COGNICIÓN

Foco · BDNF · sueño

Semax · Cerebrolysin · Selank · Ipamorelin nocturno · Epithalon. Trabajo cognitivo prolongado, post-conmoción, restauración del sueño.

CAPÍTULO III · FUNDAMENTO CELULAR

Cartas de instrucción que tu cuerpo ya sabe leer.

Un péptido es una cadena de entre dos y cincuenta aminoácidos. Tu cuerpo fabrica miles cada día. Funcionan como mensajeros: una célula los libera, otra los recibe, el mensaje ejecuta una acción específica.



CROMATOGRAFÍA HPLC DE UN LOTE BPC-157 · PICO ÚNICO A 99.4% · JANOSHIK 2026

MENSAJEROS, NO FÁRMACOS

A diferencia de un fármaco sintético, un péptido administrado de forma exógena **amplifica una señal que tu cuerpo ya emite**. No crea respuesta artificial: refuerza un canal endógeno que con la edad pierde volumen. La GH cae ~14% por década después de los 30; NAD+ muscular, ~50% entre los 20 y 60 (Verdin 2015); GHK-Cu cutáneo, 60–70% en el mismo rango.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea (SC) es el estándar para 80% de péptidos research-grade. Aguja 31G corta, 8 mm, abdomen/muslo/tríceps. **Topical** para GHK-Cu y AHK-Cu (serum 0.05–1%). **Intranasal** para neuropéptidos rusos (Semax, Selank) — ruta directa al SNC vía bulbo olfatorio. **Oral entérico** sólo para BPC-157 y KPV con cubierta resistente a pH gástrico.

POR QUÉ LA TEMPERATURA IMPORTA

Los péptidos son **moléculas frágiles**. La forma liofilizada (polvo seco) es estable durante meses a temperatura ambiente. Una vez reconstituida con agua bacteriostática, la solución es estable **~28 días refrigerada a 2–8 °C**. Congelar fragmenta el enlace peptídico por cristalización; agitar violentamente rompe la estructura terciaria. Estas dos malas prácticas explican la mayoría de protocolos "que no funcionaron".

CÓMO SE MIDE UN PROTOCOLO

Cada línea PEPTIQ documenta cinco variables: **dosis** (µg o mg), **frecuencia**, **vía**, **duración del ciclo** y **timing circadiano**. Los secretagogos GH se administran 30 min pre-sueño para no interferir con el pulso natural; Tesamorelin en ayuno matinal para evitar bloqueo por insulina. Tracking honesto: cuaderno + Oura/Whoop + hsCRP + glucosa en ayunas.

AVISO EDITORIAL

Esta guía describe protocolos reportados en **literatura peer-reviewed**. No constituye consejo médico ni sustituye consulta con profesional certificado. Los compuestos PEPTIQ son material para investigación de laboratorio; no aprobados por COFEPRIS ni FDA para uso humano.

CAPÍTULO IV · VERIFICACIÓN DE PUREZA

Verificado por el laboratorio más **confiable** del mundo.

No tienes que confiar en nuestra palabra. Cada lote PEPTIQ es auditado por un tercero independiente, acreditado bajo ISO/IEC 17025:2017 — y el resultado es público.



Síntesis farmacéutica

PEPTIQ trabaja con un laboratorio farmacéutico de síntesis peptídica research-grade — el mismo nivel de proveedor que abastece a clínicas longevity premium en EE.UU. y Europa Occidental.



Janoshik · Praga

El laboratorio independiente más respetado a nivel mundial en verificación de péptidos. Audita cada lote por HPLC; resultado firmado, público, ISO/IEC 17025:2017.



COA público por lote

El Certificate of Analysis con pureza HPLC real ($\geq 99\%$ individuales · $\geq 97\%$ blends) se publica en peptiqmx.com/verify. Tu lote específico, accesible cualquier día.



Chip NFC en cada caja

Acercas tu celular al sello holográfico — el COA del lote se abre en un segundo, sin app intermediaria. Lo que el 53% del mercado mexicano no puede hacer.

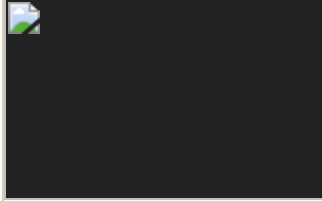
LA REGLA PEPTIQ

"Si no se puede verificar · no entra al catálogo. Si HPLC muestra menos de 99% pureza · se rechaza el lote."

CAPÍTULO V · ÍNDICE VISUAL

Las catorce líneas. Un solo estándar.

De recuperación deportiva a longevidad celular, de estética dérmica a recomposición agresiva. Cada línea ocupa entre dos y tres páginas con mecanismo, protocolo, stack y bibliografía.

 01 · RECOVERY <i>Wolverine</i> BPC-157 + TB-500	 02 · GLOW <i>GLOW Trinity</i> BPC + GHK-Cu + TB	 03 · LONGEVIDAD <i>Highlander</i> NAD+ + Epithalon	 04 · PERFORMANCE <i>Prime Titan</i> Tesa + CJC + Ipa
 05 · COMPOSICIÓN <i>Shred</i> Reta · Sema · CagriSema	 06 · SUEÑO <i>Sleep Reset</i> Ipamorelin + Epithalon	 07 · VITALIDAD <i>Vitality</i> PT-141 + Kisspeptin	 08 · COGNICIÓN <i>Neuro</i> Semax + Cerebrolysin
 09 · VISCERAL <i>Visceral Cut</i> Tesamorelin mono	 10 · CABELLO <i>GLOW Cabello</i> AHK-Cu folicular	 11 · MENOPAUSIA <i>Menopause Reset</i> Kiss + GHK-Cu + Ipa	 12 · INTESTINO <i>Gut Reset</i> BPC-157 + KPV
 13 · NEURO+	 14 · METABÓLICO		



RECOVERY · TENDÓN · LIGAMENTO

Wolverine

BPC-157 + TB-500 · 20mg blend

Protocolo de referencia para lesión de tejido blando. BPC-157 (15 aa, citoprotector gástrico) regula al alza VEGFR2 e induce angiogénesis local; TB-500 / Thymosin β -4 (43 aa) moviliza citoesqueleto de actina. Sinergia documentada: TB-500 trae la cuadrilla, BPC-157 le da el suministro vascular.

Vía SC **Dosis** 250 μ g BPC + 500 μ g TB **Ciclo** 6 sem

USOS REPORTADOS EN LITERATURA

- Tendinopatía de Aquiles, rotuliana, epicondilitis
- Esguinces grado I y II · post-cirugía ortopédica
- Úlcera gástrica · enfermedad inflamatoria intestinal
- Fascitis plantar crónica · túnel carpiano
- Reparación post-rotura muscular

STACK TÍPICO

Wolverine + colágeno hidrolizado oral 10–15 g/día + vitamina C 1–2 g/día (cofactor de prolil hidroxilasa). En lesiones articulares, BPC-157 administrado **cerca del sitio** según Chang 2011 supera a la administración distal.

PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FREC.	VÍA	CICLO
BPC-157	250–500 μ g/d	1–2x/d	SC	4–8 sem
TB-500	2–5 mg/sem	2–3x/sem	SC	4–6 sem
Wolverine BB20	250+500 μ g	1x/d	SC	6 sem

SEGURIDAD

Perfil favorable en preclínica (hasta 500 μ g/kg sin toxicidad). **Embarazo, lactancia, pediátricos:** contraindicación absoluta. **Cáncer activo o reciente:** evitar péptidos angiogénicos hasta consulta oncológica.

Fuentes: Chang CH et al. *J Appl Physiol* 2011 (21293447) · Seiwert S et al. *Curr Pharm Des* 2018 (29345571) · Goldstein AL et al. *Ann NY Acad Sci* 2012 (22882274) · Sikiric P et al. *J Physiol Paris* 2014 (25173697) · Huang T et al. *Curr Pharm Des* 2019 (30864498).



★ GLOW · REGENERACIÓN CUTÁNEA

GLOW Trinity

BPC-157 + GHK-Cu + TB-500 · 70mg

Protocolo estético de referencia adoptado por clínicas dermatológicas premium. Combina inflamación sistémica reducida (BPC-157), inducción de colágeno tipo I y III (GHK-Cu) y migración de células madre dérmicas (TB-500). Ciclo estándar: ocho semanas, fotos día 0 · 28 · 56.

Vía SC nocturna Dosis 2–3 mg/día Ciclo 8 sem on / 4 off

GHK-CU · EL MECANISMO

Tripéptido endógeno de cobre (Gly-His-Lys-Cu²⁺) presente en plasma humano. En piel, baja 60–70% entre los 20 y 60 (Pickart 2018). Se une al receptor DDR2 y activa TGF-β1 en fibroblastos dérmicos, induciendo síntesis de colágeno I/III, elastina y proteoglicanos. En ensayos cutáneos de 12 semanas: reducción de hasta **70% en profundidad de arrugas**.

POR QUÉ EL STACK TRINITY FUNCIONA

BPC-157 reduce inflamación de base (TNF-α, IL-6) — sin esto, el colágeno nuevo se fragmenta apenas se sintetiza.

GHK-Cu es el motor anabólico: matriz, elastina, proteoglicanos. **TB-500** moviliza células madre dérmicas a zonas a reparar.

PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FREC.	VÍA	CICLO
Trinity GLOW70	2–3 mg/d	Diaria	SC abd	8 sem
GHK-Cu topical	1% serum	2x/d	Cara/cuello	Indef.
AHK-Cu	0.5–1 mg	3x/sem	SC mesoter.	12 sem

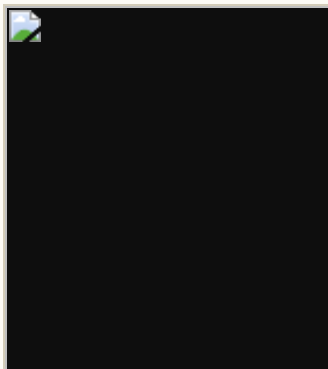
STACK TÍPICO

Trinity inyectable + GHK-Cu topical 2x/día + protector solar mineral FPS 50 (no negociable: UV degrada todo colágeno nuevo) + retinol 0.3% nocturno + sueño 7+ h.

SEGURIDAD

Perfil robusto. Eritema transitorio raro (24–48 h). **Evitar en enfermedad de Wilson**. No combinar con vitamina C en la misma aplicación: cobre y ascorbato compiten redox.

Fuentes: Pickart L, Margolina A. *Biomed Res Int* 2018 (29854759) · Pyo HK et al. *Biol Pharm Bull* 2007 (17202654) · Pickart L. *J Biomater Sci* 2008 (18534080) · Gruchlik A et al. *Acta Pol Pharm* 2014 (24779203).



LONGEVIDAD · MITOCONDRIA · TELÓMEROS

Highlander

NAD+ + Epithalon + GHK-Cu

Stack fundacional del programa de longevidad. NAD+ restaura la moneda energética celular — el cuerpo pierde ~50% entre los 20 y 60 años en músculo esquelético (Verdin 2015). Epithalon protege el extremo del cromosoma; en modelos murinos, extiende vida media (Anisimov & Khavinson 2010).

Vía SC AM **NAD+** 50–100 mg/d **Ciclo** 10 ON / 20 OFF

NAD+ · QUÉ HACE

Nicotinamida adenina dinucleótido — la **molécula que conecta tu dieta con la energía celular**. Cada ATP requiere NAD+ como aceptor de electrones. Sustrato obligatorio de sirtuinas (SIRT1–7) y PARP, enzimas que regulan reparación de ADN, expresión génica y metabolismo. La caída con la edad correlaciona con fatiga, resistencia a insulina, recuperación lenta y deterioro cognitivo subclínico.

Reponer NAD+ por SC o IM es metodológicamente más limpio que precursores orales (NMN, NR), porque evita pérdida hepática de primer paso.

EPITHALON · QUÉ HACE

Tetrámero sintético (Ala-Glu-Asp-Gly) descubierto por Khavinson en San Petersburgo. Khavinson 2003: **induce actividad de telomerasa** en fibroblastos humanos, extendiendo longitud telomérica y vida replicativa. Anisimov & Khavinson 2010 reportaron extensión de vida media en murinos — uno de los pocos compuestos con datos de longevidad en mamíferos.

PÉPTIDO	DOSIS	VÍA	CICLO
NAD+ NJ1000	50–100 mg/d	SC/IM	10 ON / 20 OFF
Epithalon ET50	5–10 mg/d	SC	10 d · 2x/año
GHK-Cu CU100	1–2 mg/d	SC abd	30 d

TIP CLÍNICO — LA PRIMERA DOSIS DE NAD+

La inyección SC de NAD+ a dosis completa (100 mg) es **incómoda los primeros 5–10 minutos**: calor, opresión torácica leve, urgencia urinaria. Es transitoria y autolimitada, no es alergia. Estrategia: **25 mg día 1, escalar a 50, luego a 100**, administrar lentamente (60 segundos, no 5).

Fuentes: Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. *Cell Metab* 2018 (29514064) · Verdin E. *Science* 2015 (26785480) · Khavinson VK et al. *Bull Exp Biol Med* 2003 (14523535) · Anisimov VN, Khavinson VK. *Biogerontology* 2010 (19802582).



★ PERFORMANCE · COMPOSICIÓN EJECUTIVA

Prime Titan

Tesamorelin + CJC-1295 + Ipamorelin

No inyectamos hormona de crecimiento sintética. Le pedimos a tu hipófisis que libere más de la tuya. CJC-1295 + Ipamorelin amplifican el pulso nocturno endógeno; Tesamorelin es el único secretagogo GHRH aprobado por la FDA — actúa específicamente sobre grasa visceral (–15% en 26 semanas, Falutz NEJM 2007).

Tesa 1–2 mg AM ayuno **CJC+Ipa** 100+200 µg PM **Ciclo** 12–16 sem

PULSÁTIL, NO SOSTENIDO

Tu hipófisis libera GH en **pulsos discretos** durante sueño profundo (fases 3 y 4). La rHGH satura el receptor 24 h y dispara mecanismos compensatorios — al discontinuar, produces menos GH endógena. Los secretagogos como CJC-1295 e Ipamorelin **amplifican el pulso natural** sin destruir el patrón circadiano. Al discontinuar, regresas a baseline sin caída adicional.

TESAMORELIN · EL ESPECÍFICO

Único GHRH **aprobado FDA** (lipodistrofia HIV, Falutz NEJM 2007). Reduce **grasa visceral** específicamente — el tejido que rodea órganos abdominales y predice riesgo cardiometabólico. No es para pérdida de peso global; es para recomposición.

PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FREC.	TIMING
CJC + Ipa CP10	100+200 µg	5n/sem	30 min pre-sueño
Tesamorelin TSM10	1–2 mg	Diaria	AM ayuno
Ipamorelin solo	200–300 µg	5n/sem	Pre-sueño

REGLA DE ORO · AYUNO

No comer azúcares ni carbohidratos densos en las 2 h previas y posteriores a la inyección. La insulina elevada bloquea la liberación de GH inducida. Es el punto único más importante del protocolo y el que se ignora en el 80% de ciclos fallidos.

SEGURIDAD

Retención de líquidos transitoria, hormigueo en manos, somnolencia post-dosis (deseable: pulso GH activo). Vigilar **glucosa en ayunas y HbA1c**: GH eleva ligeramente la glucemia. **Contraindicado** en cáncer activo, embarazo, lactancia, retinopatía diabética. No combinar con rHGH.

Fuentes: Teichman SL et al. *JCEM* 2006 (16352683) · Raun K et al. *Eur J Endocrinol* 1998 (9849822) · Falutz J et al. *NEJM* 2007 (18032763) · Stanley TL et al. *JAMA* 2014 (24449315).



★ PÉRDIDA DE PESO · TRIPLE AGONISTA

Shred

Retatrutide · Semaglutide · CagriSema

La generación nueva de análogos de incretinas. Semaglutide actúa sobre GLP-1; CagriSema combina GLP-1 + análogo de amilina; Retatrutide es el primer agonista triple GLP-1/GIP/glucagón. Pérdidas reportadas en literatura clínica: hasta **24% de masa corporal en 48 semanas** (Jastreboff NEJM 2023).

Vía SC semanal Titulación escalada Ciclo 24–48 sem

MECANISMO

Semaglutide: análogo GLP-1, retrasa vaciamiento gástrico, modula saciedad hipotalámica, mejora secreción insulina. STEP-1: 15% pérdida (Wilding 2021). **CagriSema** añade análogo de amilina — saciedad por vía distinta, mejor adherencia (Frias Lancet 2023). **Retatrutide** agonista triple — el glucagón aumenta gasto energético basal, distinguiéndolo de los anteriores.

DIFERENCIAS PRÁCTICAS

- **Semaglutide** · efecto en apetito · sólido, predecible
- **CagriSema** · saciedad combinada · mejor adherencia
- **Retatrutide** · eleva gasto energético · curva más empinada

PROTOCOLO SUGERIDO

COMPUESTO	DOSIS INICIAL	TITULACIÓN
Semaglutide	0.25 mg/sem	Doblar c/4 sem → 2.4 mg
CagriSema	0.25 mg/sem	Hasta 2.4/2.4 mg
Retatrutide	2 mg/sem	Hasta 8–12 mg/sem

STACK TÍPICO

Análogo + **proteína 1.8–2.2 g/kg/día** + entrenamiento de fuerza 3–4x/sem + B12, D, magnesio + hidratación 35 ml/kg. La pérdida muscular es el riesgo principal de cualquier protocolo agresivo.

SEGURIDAD — CRÍTICA

Náusea, estreñimiento, reflujo (titulación rápida). **Pancreatitis** rara pero seria — vigilar dolor abdominal alto persistente.

Contraindicado en historia personal/familiar de carcinoma medular de tiroides, MEN-2, enfermedad biliar activa, embarazo, lactancia. **Riesgo regulatorio MX:** Retatrutide sin aprobación COFEPRIS — uso fuera de investigación bajo riesgo del usuario.

Fuentes: Wilding JPH et al. NEJM 2021 (33567185) · Jastreboff AM et al. NEJM 2023 (37354531) · Frias JP et al. Lancet 2023 · Garvey WT et al. Nat Med 2022.



06 · SUEÑO · ARQUITECTURA REM/DELTA

Sleep Reset

Ipamorelin nocturno + Epithalon

Ipamorelin 30 min pre-sueño amplifica el pulso nocturno de GH endógena, profundizando fases 3 y 4. Epithalon regula pineal y secreción de melatonina (Khavinson). Útil en sueño fragmentado, despertares múltiples, sensación de "no haber descansado" pese a 7+ h en cama, jet-lag persistente.

Ipa 200–300 µg pre-sueño Epi 5 mg PM · 10 d DSIP 100–200 µg opcional



07 · VITALIDAD · EJE HPG

Vitality

PT-141 + Kisspeptin

PT-141 (Bremelanotide) actúa **centralmente** sobre receptores MC3R/MC4R — efecto sobre deseo sexual, no mecánica vascular. Aprobado FDA (Vyleesi). Kisspeptin es el activador upstream de neuronas GnRH del hipotálamo: el regulador maestro del eje HPG. Skorupskaitė & George han reportado uso en hipogonadismo funcional y amenorrea hipotalámica.

PT-141 1.0–1.75 mg PRN Kiss-10 50–100 µg/kg Frec. 2–3x/sem

LÍNEA	PÉPTIDO	DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	NOTAS
06 Sleep	Ipamorelin	200–300 µg	SC	5 noches/sem	30 min pre-sueño
06 Sleep	Epithalon	5 mg	SC	Diaria · 10 d	Tarde · 2x/año
07 Vitality	PT-141	1.0–1.75 mg	SC	PRN, máx 8/mes	45 min pre-actividad
07 Vitality	Kisspeptin-10	50–100 µg/kg	SC	2–3x/sem	Pulsátil, ciclos 4 sem

SEGURIDAD

Ipamorelin: perfil muy favorable, vigilar glucosa en uso prolongado. PT-141: hiperpigmentación transitoria leve, náusea (resolución 30 min), eritema facial; cuidado en hipertensión no controlada. Kisspeptin: bien tolerado. Embarazo y lactancia: contraindicación absoluta.

Fuentes: Raun K et al. *Eur J Endocrinol* 1998 (9849822) · Khavinson VK et al. *Mech Ageing Dev* 2003 · Pfaus JG et al. *Pharmacol Biochem Behav* 2007 · Skorupskaitė K et al. *Hum Reprod Update* 2014 (24664881) · Kingsberg SA et al. *Obstet Gynecol* 2019.



08 · COGNICIÓN · BDNF · PLASTICIDAD

Neuro

Semax intranasal + Cerebrolysin

Dos neuropéptidos clásicos de la escuela rusa. Semax es fragmento de ACTH(4-10) modificado, intranasal, eleva BDNF y NGF en hipocampo y corteza prefrontal. Cerebrolysin es hidrolizado de neuropéptidos porcinos con datos en ictus y deterioro cognitivo. Vía intranasal aprovecha bulbo olfatorio — ruta directa al SNC, evita BHE.

Semax 1% 2-4 gotas/fosa Cerebro 5-10 ml IM Selank 250-500 µg ansiolítico



09 · GRASA VISCERAL · EJECUTIVO

Visceral Cut

Tesamorelin · monoterapia

No toda la grasa es igual. La visceral — la que rodea hígado, páncreas, intestino — es metabólicamente activa, inflamatoria, predictor independiente de enfermedad cardiometabólica. Tesamorelin es el único secretagogo GHRH con datos fase III específicamente sobre **reducción de grasa visceral**: -15% en 26 sem, sin cambio en masa magra (Falutz NEJM 2007).

Dosis 1-2 mg Vía SC AM ayuno Ciclo 16-26 sem

LÍNEA	PÉPTIDO	DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	CICLO
08 Neuro	Semax 1%	200-400 µg/fosa	Intranasal	2-3x/d	10-14 d
08 Neuro	Cerebrolysin	5-10 ml	IM	Diaria	10-20 d
08 Neuro	Selank	250-500 µg	Intranasal	2x/d	10-14 d
09 Visceral	Tesamorelin	1-2 mg	SC	Diaria	16-26 sem

TRACKING · VISCERAL CUT

Perímetro abdominal mensual; idealmente **DEXA o resonancia** con cuantificación de tejido adiposo visceral basal y a las 16 semanas. Sin medición objetiva, no hay ciclo evaluable. Cerebrolysin en epilepsia o riesgo convulsivo: precaución.

Fuentes: Ashmarin IP et al. *Neurochem Res* 2005 · Heiss WD et al. *Stroke* 2012 · Plosker GL, Gauthier S. *CNS Drugs* 2009 · Falutz J et al. *NEJM* 2007 (18032763) · Stanley TL et al. *Lancet HIV* 2019.



10 · CABELLO · FOLÍCULO PILOSO

GLOW Cabello

AHK-Cu · sin rebote

Tripéptido de cobre específico para folículo piloso (Ala-His-Lys-Cu²⁺). Estimula proliferación de células de la papila dérmica y prolonga fase anágena. Alternativa a minoxidil **sin shedding rebote**: AHK-Cu no sincroniza el ciclo, prolonga anágena por VEGF y proteoglicanos. Funciona si el folículo aún existe (no en Norwood VI-VII).

SC scalp 0.5–1 mg · 3x/sem **Mesoterapia** 1–2 mg c/2 sem **Topical** 0.01–0.05%



11 · MENOPAUSIA · EJE HPG FEMENINO

Menopause Reset

Kisspeptin + GHK-Cu + Ipamorelin

Soporte para perimenopausia y menopausia que actúa sobre tres ejes: regulación HPG (kisspeptin), restauración de matriz cutánea (GHK-Cu, ~30% pérdida de colágeno en primeros 5 años), soporte de sueño y composición (Ipamorelin). No reemplaza TRT — la complementa, o ofrece vía alternativa de mantenimiento estructural en pacientes no candidatas.

Kiss-10 50 µg/kg · 2x/sem **GHK-Cu** 2 mg/d · 30 d **Ipa** 200 µg pre-sueño



12 · INTESTINO · IBD · PERMEABILIDAD

Gut Reset

BPC-157 entérico + KPV

BPC-157 fue descubierto como factor citoprotector gástrico, derivado de jugo gástrico humano. KPV es el fragmento C-terminal de α-MSH, antiinflamatorio potente con afinidad selectiva por mucosas. BPC-157 entérico restaura tight junctions (claudina, ocludina). KPV inhibe NF-κB; reduce TNF-α, IL-1β, IL-6 sin inmunosupresión sistémica. Stack de referencia para EII en preclínica.

BPC oral 500 µg · 2x/d **KPV oral** 200–400 µg · 1–3x/d **Ciclo** 8–12 sem

COORDINACIÓN CLÍNICA · MENOPAUSE

Pensado para **uso en clínica** bajo supervisión ginecológica. Integración con TRT, tamizaje oncológico, densitometría ósea y perfil cardiometabólico anual es indispensable. PEPTIQ ofrece el material como referencia para conversación con especialista, no como sustituto de evaluación clínica.

Fuentes: Pyo HK et al. *Biol Pharm Bull* 2007 (17202654) · Trüeb RM. *Int J Trichology* 2009 · Skorupskaitė K et al. *Hum Reprod Update* 2014 · Pickart L, Margolina A. *Biomed Res Int* 2018 · Sikiric P et al. *J Physiol Paris* 2014 · Kannengiesser K et al. *Inflamm Bowel Dis* 2008 (18200517) · Luger TA, Brzoska T. *Ann NY Acad Sci* 2007.

Tu objetivo, tu línea.

Esta matriz mapea los doce objetivos más frecuentes en consulta hacia la línea PEPTIQ correspondiente. Es punto de partida; un protocolo final se individualiza considerando edad, perfil hormonal, historia oncológica, medicación crónica y objetivos a 6–12 meses.

OBJETIVO PRINCIPAL	LÍNEA	COMPONENTES	CICLO TÍPICO	TICKET APROX.
Lesión deportiva · tendón · ligamento	Wolverine	BPC-157 + TB-500	6–8 sem	\$5,499
Piel · arrugas · firmeza	GLOW Trinity	Trinity blend + GHK-Cu topical	8 sem	\$7,499
Energía · longevidad sistémica	Highlander	NAD+ + Epithalon + GHK-Cu	30 d intermitente	\$14,999
Composición corporal · masa magra	Prime Titan	Tesamorelin + CJC + Ipa	16 sem	\$14,999
Pérdida de peso significativa	Shred	Retatrutide o Semaglutide	24–48 sem	\$12,999+
Sueño fragmentado · fatiga matinal	Sleep Reset	Ipamorelin + Epithalon	8 sem	\$5,499
Libido · vitalidad sexual	Vitality	PT-141 + Kisspeptin	PRN + ciclos	variable
Foco · cognición · post-conmoción	Neuro	Semax + Cerebrolysin	10–14 d	\$8,999
Grasa visceral aislada	Visceral Cut	Tesamorelin monoterapia	16–26 sem	\$7,499/mes
Caída de cabello androgenética temprana	GLOW Cabello	AHK-Cu mesoterapia	12–20 sem	\$3,799/mes
Perimenopausia · sueño · piel · libido	Menopause Reset	Kiss + GHK-Cu + Ipa	3 meses	consultar
Crohn · CU · intestino permeable	Gut Reset	BPC-157 entérico + KPV	8–12 sem	\$5,999

01 · MARCADOR

¿Qué vas a medir?

Sin marcador, no hay protocolo serio. Define qué medir y cuándo: dolor 0–10, fotos día 0/28/56, hsCRP, edad biológica, perímetro abdominal. Sin

02 · FISIOLÓGÍA BASAL

¿Estás listo?

Los péptidos amplifican señales endógenas. Antes de cualquier ciclo: panel hormonal (T total/libre, E2, TSH, T4, IGF-1, cortisol), HbA1c, HOMA-IR,

03 · CONTRAINDICACIÓN

¿Tienes alguna?

Cáncer activo o reciente
contraindica angiogénicos (BPC, TB, GHK, GH-secretagogos). Embarazo y lactancia: absolutas.

CAPÍTULO VII · OPERACIÓN

Reconstitución & cálculo de dosis.

Los péptidos llegan en polvo liofilizado para máxima estabilidad. Antes de cada ciclo, se reconstituyen con agua bacteriostática. Siguiendo el protocolo correcto, la solución es estable ~28 días refrigerada a 2–8 °C.

PROTOCOLO PASO A PASO

- 01 Lava manos.** Desinfecta el septum del vial liofilizado y del agua bacteriostática con isopropílico al 70%. Espera 30 segundos a que evapore.
- 02 Carga la jeringa con agua bacteriostática.** Volumen típico: 2 mL por vial de 10 mg (resultante: 5 mg/mL = 5000 µg/mL).
- 03 Inyecta el agua escurriéndola por la pared interna del vial,** no directamente sobre el polvo. Previene espuma y agregación.
- 04 Deja reposar 60 segundos. No agites.** Rota suavemente entre las palmas hasta disolución completa (1–3 min).
- 05 Etiqueta con fecha** en marcador permanente sobre la tapa. Refrigerar a 2–8 °C (no congelador, no puerta).
- 06 Carga cada dosis** con jeringa U-100 estéril nueva. Nunca recargues una jeringa usada.

ERRORES FRECUENTES

- **Agitar violentamente** · rompe estructura terciaria. Solo rotar.
- **Agua destilada simple** · sin alcohol bencílico al 0.9% no hay conservador; contaminación en 48–72 h.
- **Congelar la solución** · cristalización fragmenta el enlace, irreversible.
- **Vial a temperatura ambiente >1 h** · acelera degradación.
- **Mezclar dos péptidos en la misma jeringa** · incompatibilidades químicas.
- **Reutilizar agua bacteriostática** · vial 3 mL → máx 10 punciones.

CÁLCULO · EJEMPLO BPC-157

Vial: 10 mg liofilizado.

Reconstitución: 2 mL agua bacteriostática.

Concentración: 10 mg ÷ 2 mL = **5000 µg/mL**.

Jeringa U-100: 100 u = 1 mL → 1 u = 0.01 mL = **50 µg**.

Dosis 250 µg = 250 ÷ 50 = **5 unidades**.

Dosis 500 µg = **10 unidades**.

CALCULADORA ONLINE

peptiqmx.com/calculadora · introduce dosis del vial, agua de reconstitución y dosis objetivo. Devuelve unidades exactas en jeringa U-100.

VÍAS POR PÉPTIDO

COMPUESTO	VÍA ESTÁNDAR
BPC-157, TB-500, CJC, Ipa, Tesa, Reta	SC abdomen
GHK-Cu, AHK-Cu	SC + topical
NAD+	SC o IM lenta
Semax, Selank	Intranasal
Cerebrolysin	IM
BPC-157, KPV (Gut Reset)	Oral entérico



CADA CAJA · NFC INTEGRADO BAJO EL SELLO HOLOGRÁFICO

CAPÍTULO VIII

Verificación de lote.

Cada caja PEPTIQ incluye un chip NFC bajo el sello holográfico que abre directamente el COA público del lote. Sin app intermediaria, sin registro.

- 01** **Acerca el teléfono** al sello. iPhone XS+ o Android moderno con NFC habilitado.
- 02** **Verifica número de lote** · debe coincidir con caja y vial.
- 03** **Lee el cromatograma HPLC** · pico único limpio >99% (individuales) o >97% (blends).
- 04** **Verifica fecha de análisis** · COA emitido en los últimos 12–18 meses.
- 05** **Cruza con espectrometría de masas** · peso molecular ± 0.5 Da del teórico.

Si recibes un lote cuyo COA no carga, no coincide o cuya pureza es inferior al umbral: peptiqmx.com/garantia-coa reembolsa el lote completo sin discusión.

IX · PROGRAMA B2B · CLÍNICAS PARTNER

Para clínicas de medicina estética, longevidad, hormonal y deportiva.

MARGEN PARTNER

Pricing mayoreo con descuentos 15–35% según volumen mensual. Margen final clínica 40–60% sobre tarifa concierge. Factura con IVA, plazos a 30 días.

SOPORTE CLÍNICO

Material editorial de marca blanca. Llamadas de protocolo con tu equipo médico. Templates de consentimiento informado. Investigador dedicado por WhatsApp.

WHITE-LABEL

Volumen ≥ 200 viales/mes: línea con tu marca, COA Janoshik público bajo lote correspondiente. Empaque negro mate, holográfico, NFC integrado.

14 líneas activas · 99%+ pureza HPLC · 100% COA público · Entrega 24h CDMX/MTY/GDL · Onboarding en <7 días hábiles · peptiqmx.com/b2b-clinicas

Pureza que no se declara. Se verifica.

Esta guía documenta los protocolos que usan nuestras clínicas partner y nuestros sujetos de investigación. Escríbenos por WhatsApp y te mandamos el COA Janoshik del lote vigente — antes, no después, de tu compra.

WHATSAPP

+52 1 444 577 0445

EMAIL

hola@peptiqmx.com

WEB

peptiqmx.com

VERIFICA TU LOTE

peptiqmx.com/verify

CLÍNICAS B2B

peptiqmx.com/b2b-clinicas

INSTAGRAM

@peptiqmx

FORMAS DE PAGO · ENTREGA 24H CDMX · MTY · GDL

Tarjeta crédito/débito · 3, 6 y 9 MSI · Transferencia SPEI · Bitcoin (–10% off) · OXXO · Stripe checkout · Factura con IVA 100% deducible disponible

Aviso regulatorio · Research Use Only · Los productos PEPTIQ MX son péptidos de investigación científica (research-grade compounds) destinados exclusivamente a uso profesional en laboratorios, investigación académica y estudios clínicos autorizados. **No están aprobados por COFEPRIS ni FDA para uso humano.** No deben ser administrados ni consumidos por personas. La documentación describe dosis, frecuencias y protocolos reportados en literatura peer-reviewed con fines exclusivamente informativos. **El uso es responsabilidad única y exclusiva del adquirente.** PEPTIQ MX no asume responsabilidad por aplicaciones fuera del contexto de investigación. Cada lote es analizado por **Janoshik Analytical (Praga, ISO/IEC 17025:2017)**; COA público en peptiqmx.com. Lector declara **ser mayor de edad (18+)** y actuar bajo su propia responsabilidad. Se recomienda consultar con profesional de la salud certificado antes de cualquier protocolo. PEPTIQ MX · Edición 2026 · Volumen I.